

Cours De Résidanat

Sujet 22

Douleurs thoraciques aiguës

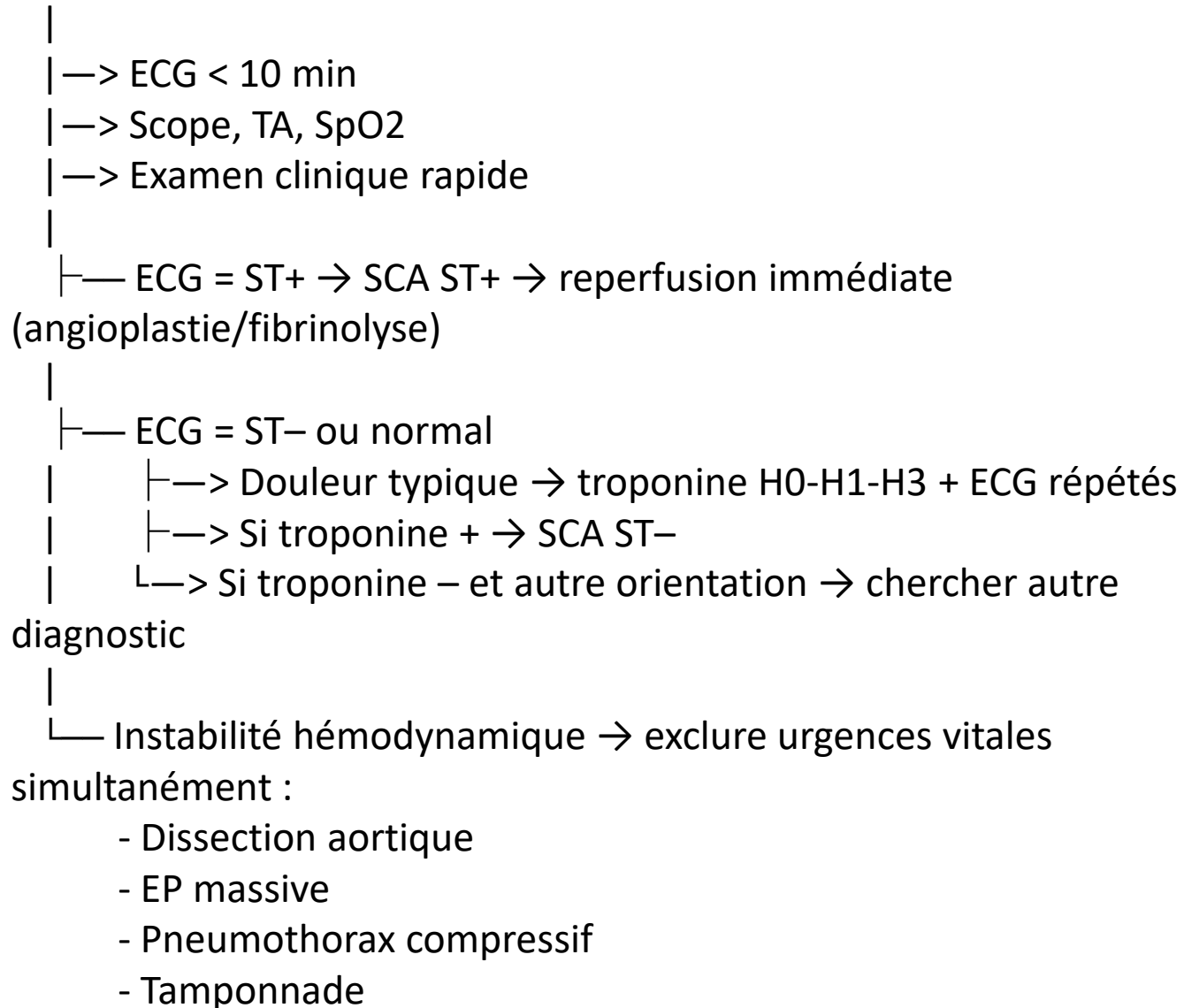
Orientation diagnostique

Concours ECN 2025

Pr Ag Amine BAHLOUL

Algorithme global – Douleur Thoracique

Douleur thoracique → ÉVALUATION IMMÉDIATE



Algorithme – SCA

Douleur thoracique constrictive prolongée

- |
- | —> ECG < 10 min
- |
- | — ST+ convexe ≥ 2 dérivations contiguës
 - | → Reperfusion immédiate (angioplastie si <120 min, sinon fibrinolyse)
- |
- | — ECG ST- ou normal
 - | → Troponine US H0-H1-H3
 - | —> + → SCA ST-
 - | —> - → répéter si suspicion forte

Algorithme – SCA

1. Douleur angineuse typique : constrictive, rétrosternale, irradiant bras/mâchoire, >20 min, résistante trinitrine (si ST+)
2. Douleur atypique chez diabétique, sujet âgé, femme : parfois absente.
3. SCA ST+ : sus-décalage ST persistant ≥ 2 dérivations contiguës.
4. SCA ST– : sous-décalage ST, ondes T plates/négatives/biphasiques.
5. ECG normal en intercritique **n'exclut pas** un SCA ST–
6. Troponine ultrasensible = marqueur spécifique (positive si IDM, normale possible si angor instable).
7. Ne jamais attendre troponine pour diagnostiquer SCA ST+.
8. Examen clinique souvent pauvre.

Algorithme – Dissection de l'aorte

Douleur thoracique brutale, transfixiante, migratrice

- | —> Examen clinique : asymétrie TA, souffle IA, déficit neuro ?
- |
- | — Suspicion faible → D-dimères
 - | —> négatifs = éliminent
- |
- | — Suspicion forte ou intermédiaire
 - | —> Patient stable : angioscanner thoraco-abdomino-pelvien
 - | —> Patient instable : ETO au lit ou ETT si tamponnade
- |
- | — Stanford :
 - Type A (ascendante) → chirurgie urgente
 - Type B (descendante) → TTT médical ± endovasculaire

Algorithme – Dissection de l'aorte

1. Douleur thoracique brutale, maximale d'emblée, transfixiante, migratrice (dos, lombes).
2. Terrain : HTA, Marfan, post-partum, bicuspidie, antécédents de DA.
3. Asymétrie tensionnelle ≥ 20 mmHg / asymétrie des pouls.
4. Souffle d'insuffisance aortique aiguë.
5. Complications : AVC, ischémie MI, insuffisance rénale, tamponnade.
6. Radio thorax : médiastin élargi, cœur en carafe si hémopéricarde.
7. D-dimères bas valeur prédictive négative si faible probabilité.
8. Examen clé : angioscanner thoraco-abdomino-pelvien (référence).
9. Classification Stanford : A (ascendante, chirurgicale urgente), B (descendante).

Algorithme – Embolie pulmonaire

Dyspnée brutale +/- douleur basi-thoracique

- | —> Calcul score de Wells (simplifié)
- |
 - | — Wells < 2 = proba faible → D-dimères
 - | —> normaux → élimine
 - | —> positifs → angioscanner
 - | — Wells ≥ 2 = proba forte
 - Angioscanner thoracique
 - Si état instable : échographie cardiaque au lit (signe CPA)
- | — Alternatives si CI scanner :
 - Scintigraphie V/Q
 - Doppler MI

Algorithme – Embolie pulmonaire

1. Dyspnée brutale ++, douleur basi-thoracique en coup de poignard, hémoptysie possible.
2. Terrain : MTEV, chirurgie, immobilisation, cancer, post-partum.
3. Examen souvent pauvre : polypnée, tachycardie, auscultation normale possible.
4. Score de Wells simplifié : ≥ 2 = EP probable.
5. Radiographie souvent normale.
6. ECG : tachycardie sinusale ++, S1Q3, T négatives V1–V3.
7. GDS : hypoxie-hypocapnie-alcalose respiratoire.
8. D-dimères normaux éliminent EP si faible probabilité.
9. Examen de référence : angioscanner thoracique.
10. Alternatives : scintigraphie V/Q, ETT (VD dilaté), Doppler MI.

Algorithme – Péricardite aiguë

Douleur précordiale

- majorée décubitus, inspiration
- soulagée antéflexion

|

|—> ECG

|

- ST diffus concave

|

- PQ sous-décalé

|

|—> Écho cardiaque (recherche épanchement, tamponnade)

|

|—> Biologie (CRP, troponine)

Algorithme – Péricardite aiguë

1. Douleur précordiale, augmentée par l'inspiration/décubitus, soulagée par l'antéflexion.
2. Frottement péricardique pathognomonique.
3. ECG en 4 stades (Holzmann) : ST diffus concave sans miroir + PQ sous-décalé → T aplaties → T négatives → normalisation.

Algorithme – Causes respiratoires

Pneumothorax : Douleur brutale + dyspnée

- |
- | — Stable → radio thorax
 - | —> petit PNO < 2cm → surveillance
 - | —> large ou symptomatique → drainage
- |
- | — Instable → drainage immédiat sans imagerie

Pneumonie : Fièvre + toux + crépitants

- |
- | —> Radio thorax : foyer systématisé
- | —> NFS/CRP, hémocultures
- |
- | —> Gravité (CRB65) → hospitalisation si score ≥ 1

Pleurésie : Douleur coup de poignard + matité

- |
- | —> Radio thorax : opacité déclive
- | —> Ponction pleurale (diagnostique)

Algorithme – Causes respiratoires

Pneumothorax spontané

1. Douleur thoracique brutale, latérothoracique, coup de poignard, dyspnée.
2. Terrain typique du PNO : homme jeune, longiligne, tabagique.
3. À l'auscultation : abolition du murmure vésiculaire + tympanisme.
4. Forme grave : PNO compressif → signes de choc + déviation trachéale.
5. Radiographie thoracique = diagnostic (décollement pleural, hyperclarté).

Algorithme – Causes respiratoires

Pneumonie

1. Début fébrile, toux productive, dyspnée, douleurs basi-thoraciques.
2. Examen : râles crépitants, souffle tubaire.
3. Radio thorax : foyer alvéolaire systématisé.
4. Syndrome infectieux biologique : hyperleucocytose, CRP élevée.
5. Complication : pleurésie parapneumonique.

Algorithme – Causes respiratoires

Pleurésie

1. Douleur basi-thoracique en coup de poignard, augmentée par l'inspiration.
2. Trépied pleurétique : douleur + toux sèche + dyspnée.
3. À l'examen : matité + abolition du MV.
4. Radio thorax : opacité liquidienne déclive, ligne de Damoiseau.
5. Étiologies : infectieuse, néoplasique, tuberculeuse.

Algorithme – Causes non cardiaques non respiratoires

Douleur pariétale : Douleur pariétale: Douleur localisée, reproduite palpation

→ Pas d'examens urgents

Douleur oesophagienne : Brûlure rétro-sternale post-prandiale

→ Test IPP

→ FOGD si atypie/persistance

Douleur neurologique : Zona (douleur en bande, vésicules)

→ Clinique

Algorithme – Causes non cardiaques non respiratoires

1. **Douleur pariétale** : reproduite par la palpation, typique du syndrome de Tietze.
2. **Douleur œsophagienne** : brûlure rétrosternale, rythmée par les repas, reflux/pyrosis.
3. Spasme œsophagien : douleurs constrictives imitant angor, sensibles aux dérivés nitrés.
4. **Douleur neurologique** : zona (vésicules en dermatome), névralgie intercostale, douleur vertébrale.

Algorithme – Causes extra-thoraciques

Douleur abdominale projetée

- Pancréatite → épigastrique transfixiante + lipase ↑
- Cholécystite → HCD fébrile
 - Scanner/écho abdominale selon le cas

Douleur psychogène

- Douleur variable, contexte anxieux, ECG normal
- Exclure urgences par ECG/troponine
 - Prise en charge psychiatrique

Algorithme – Causes extra-thoraciques

1. **Douleur abdominale projetée** : pancréatite (douleur transfixiante épigastrique), cholécystite (hypochondre droit), ulcère GD.
2. **Douleur psychogène** : souvent atypique, non systématisée, contextuelle, variable avec l'anxiété.

1. Homme 58 ans, douleur rétrosternale constrictive irradiant vers le bras gauche, 45 min, résistante au TNT. À l'ECG, sus-décalage ST en DII, DIII, aVF.

Quels éléments sont corrects ?

- A. Diagnostic de SCA ST+
- B. Nécessité de confirmer par troponine avant de débuter la reperfusion
- C. Concerne le territoire inférieur
- D. Peut être un angor instable
- E. Contre-indication au traitement urgent si troponine normale

Réponse : A, C

2. Lequel est FAUX concernant le SCA ?

- A. La douleur peut être épigastrique
- B. L'ECG peut être normal en intercritique
- C. La troponine ultrasensible est toujours normale dans l'angor instable
- D. La confirmation diagnostique du SCA ST+ est biologique
- E. L'ECG doit être fait dans les 10 min

Réponse : D

3. Parmi les signes évocateurs d'une dissection aortique, on retrouve :

- A. Douleur transfixiante migratrice
- B. Souffle diastolique d'IA aigüe
- C. Asymétrie tensionnelle
- D. Hémoptysie massive inaugurale
- E. Médiastin élargi à la radiographie

Réponse : A,B,C,E

4. Concernant la classification de Stanford :

- A. Type A = aorte ascendante
- B. Type A = traitement chirurgical urgent
- C. Type B = aorte ascendante
- D. Type B peut relever d'un traitement médical initial
- E. Le type A correspond toujours à une dissection descendante

Réponse : A,B,D

5. Quel est le signe clinique le plus constant dans l'EP ?

A. Hémoptysie

B. Polypnée

C. Douleur thoracique pleurétique

D. Fièvre > 39°C

E. Auscultation anormale systématique

Réponse : B

6. Femme 35 ans, pilule, dyspnée brutale, tachycardie 120/min, radio normale.
Score de Wells = 3.

Conduite à tenir ?

- A. Dosage des D-dimères
- B. Angioscanner thoracique en urgence
- C. Écho cardiaque systématique en première intention
- D. Coronarographie urgente
- E. Simple surveillance

Réponse : B

7. Quels examens peuvent confirmer une EP ?

- A. Angioscanner thoracique
- B. Scintigraphie V/Q
- C. ECG
- D. D-dimères
- E. Échographie cardiaque transthoracique (en cas de CPA)

Réponse : A, B, E

8. Homme 28 ans, douleur précordiale augmentée en décubitus, soulagée par l'antéflexion, fébricule.

Quels éléments confirment la péricardite ?

- A. Frottement péricardique à l'auscultation
- B. ECG : ST diffus concave sans miroir
- C. Troponine systématiquement élevée
- D. Douleur améliorée par TNT immédiate
- E. Douleur soulagée par la position d'antéflexion

Réponse : A, B, E

9. Concernant les stades ECG de la péricardite :

- A. Stade 1 : ST concave diffus, PQ sous-décalé
- B. Stade 2 : normalisation de ST, T aplaties
- C. Stade 3 : ondes T négatives
- D. Stade 4 : normalisation complète
- E. Stade 1 : sus-décalage ST localisé avec miroir

Réponse : A, B, C,D

10. Chez un patient avec douleur thoracique, quel ECG impose une reperfusion immédiate ?

- A. Sous-décalage ST diffus
- B. Sus-décalage ST convexe en haut dans ≥ 2 dérivations contiguës
- C. Onde T négative isolée en V1-V3
- D. ECG strictement normal
- E. BBG complet récent

Réponse : B, E

11. Concernant la biologie dans le SCA :

- A. La troponine est toujours positive dans le SCA ST+
- B. Le dosage ne doit jamais retarder la reperfusion
- C. Une troponine normale élimine un SCA sans sus-décalage
- D. L'angor instable correspond à une troponine normale
- E. L'IDM sans onde Q = troponine positive sans ST+

Réponse : A, B,D, E

12. Dans la dissection aortique, quel examen a la meilleure sensibilité en urgence ?

- A. Coronarographie
- B. Angioscanner thoraco-abdomino-pelvien
- C. Radio thorax
- D. ECG
- E. Échographie transthoracique

Réponse : B

13. Quels terrains doivent faire évoquer une dissection ?

A. Syndrome de Marfan

B. Femme en post-partum

C. Antécédent de bicuspidie aortique

D. HTA sévère

E. Tabagisme isolé

Réponse : A, B,C, D

14. Concernant l'ECG dans la dissection aortique :

- A. Il est toujours normal
- B. Peut montrer une ischémie si atteinte coronaire
- C. Est l'examen de référence
- D. Peut être confondu avec un IDM
- E. Est inutile dans le bilan initial

Réponse : B,D

15. Quel signe radiologique est en faveur d'une EP ?

- A. Signe de Westermark
- B. Atélectasie en bande
- C. Opacité triangulaire à sommet hilair
- D. Pneumothorax apical
- E. Surélévation de la coupole diaphragmatique

Réponse : A, B,C, E

16. Quels sont les signes ECG possibles dans l'EP ?

- A. Tachycardie sinusale
- B. S1Q3
- C. Onde T négatives de V1 à V3
- D. BBD
- E. ST+ diffus concave

Réponse : A, B,C,D

17. Quels éléments cliniques orientent vers un cœur pulmonaire aigu ?

- A. Reflux hépato-jugulaire
- B. Turgescence jugulaire
- C. Hépatomégalie douloureuse
- D. Frottement péricardique
- E. Pouls paradoxal

Réponse : A, B,C, E

18. Concernant le score de Wells simplifié :

A. ≥ 2 = EP probable

B. 0-1 = EP improbable

C. Intègre la fréquence cardiaque

D. Intègre les antécédents de MTEV

E. Intègre la valeur de la troponine

Réponse : A, B,C, D

19. Quels examens sont recommandés si probabilité clinique faible ?

A. Dosage D-dimères

B. Coronarographie

C. Angioscanner thoracique direct

D. Écho transœsophagienne

E. ECG

Réponse : A, E

20. Chez un patient avec EP, quels marqueurs sont de mauvais pronostic ?

- A. Troponine élevée
- B. BNP/NT-proBNP élevés
- C. Dysfonction VD à l'ETT
- D. Tachycardie sinusale à 100/mn
- E. Thrombose veineuse profonde du membre inférieur

Réponse : A, B, C

21. Chez un patient avec EP, quels marqueurs sont de mauvais pronostic ?

- A. Age jeune (< 60 ans)
- B. Contexte de néoplasie associée
- C. BPCO associée
- D. SaO₂ < 95%
- E. Cardiopathie ischémique avec altération de la fonction systolique du ventricule gauche (Fraction d'éjection = 40%)

Réponse : B, C,E

22. Quel élément est pathognomonique de la péricardite ?

A. Douleur thoracique soulagée par TNT

B. Frottement péricardique

C. ST diffus concave avec miroir

D. Fièvre

E. Dyspnée

Réponse : B

23. Quel est le profil typique de la douleur de péricardite ?

- A. Constrictive, effort-dépendante
- B. Soulagée par l'antéflexion
- C. Majorée par l'inspiration et le décubitus
- D. Irradiation typique vers le bras gauche
- E. Résistante à la TNT

Réponse : B, C, E

24. Quels signes physiques peuvent être retrouvés dans la péricardite ?

- A. Frottement péricardique fugace
- B. Turgescence jugulaire isolée
- C. Crépitants bilatéraux
- D. Frottement péricardique persistant en apnée
- E. Souffle diastolique d'insuffisance aortique

Réponse : A, D

25. Parmi les complications possibles d'une péricardite aiguë:

- A. Tamponnade
- B. Constriction péricardique
- C. Récidives
- D. Thrombo-embolie pulmonaire
- E. Insuffisance aortique aiguë

Réponse : A, B, C

26. Quel(s) examen(s) peut éliminer une embolie pulmonaire ?

- A. Scintigraphie ventilation-perfusion normale
- B. Angioscanner thoracique normal de bonne qualité
- C. ECG normal
- D. D-dimères normaux avec probabilité faible
- E. Échographie cardiaque normale

Réponse : A, B, D

27. Quels signes orientent vers une douleur thoracique d'origine non coronaire ?

- A. Soulagement par antéflexion
- B. Reproduction de la douleur à la palpation
- C. Migration de la douleur vers le dos-lombes
- D. Douleur déclenchée par l'effort
- E. Douleur augmentée à l'inspiration profonde

Réponse : A, B, C, E

28. Homme 20 ans, grand, mince, tabagique, douleur brutale hémithorax droit, dyspnée.

Quel signe clinique est le plus évocateur d'un pneumothorax ?

- A. Frottement pleural
- B. Matité basithoracique
- C. Tympanisme et abolition MV
- D. Souffle tubaire
- E. Frottement péricardique

Réponse : C

29. Le pneumothorax compressif se caractérise par :

- A. Déviation trachéale controlatérale
- B. Turgescence jugulaire
- C. Choc obstructif
- D. Râles crépitants diffus
- E. Silence auscultatoire

Réponse : A, B, C, E

30. La douleur pleurale typique est :

A. Coup de poignard basi-thoracique

B. Augmentée inspiration profonde

C. Soulagée par TNT

D. Migratrice lombaire

E. Associée à toux sèche

Réponse : A, B, E

31. À l'examen physique d'une pleurésie, on retrouve :

A. Matité basithoracique

B. Abolition MV

C. Tympanisme

D. Souffle tubaire

E. Frottement pleural

Réponse : A, B, E

32. Quel signe oriente vers une origine pariétale ?

A. Douleur reproductible à la palpation

B. Majorée à l'inspiration

C. Soulagement par antéflexion

D. Fièvre associée

E. Syndrome grippal

Réponse : A

33. Le spasme œsophagien peut :

A. Mimer une douleur angineuse

B. Être amélioré par TNT

C. Toujours donner fièvre

D. Se déclencher au repas

E. S'accompagner de dysphagie

Réponse : A, B, D, E

34. Douleur thoracique psychogène typique :

- A. Atypique, variable
- B. Reproductible par la palpation
- C. Non systématisée
- D. Déclenchée par l'anxiété
- E. Confirmée par un ECG anormal

Réponse : A, C, D

35. Une douleur soulagée par antéflexion évoque :

A. Péricardite

B. Pancréatite

C. Reflux gastro-œsophagien

D. Pneumothorax

E. Douleur psychogène

Réponse : A, B

36. Homme de 22 ans, tabagique, douleur brutale hémithorax droit, polypnée, cyanose, TA 70/40, déviation trachéale gauche.

Que faire en premier ?

- A. Radio thorax
- B. Scanner thoracique
- C. Drainage thoracique immédiat sans imagerie
- D. Gazométrie artérielle
- E. Échographie thoracique

Réponse : C

37. Patient 35 ans, douleur coup de poignard basi-thoracique, dyspnée, abolition MV bas gauche, matité.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. Pleurésie
- B. Pneumothorax compressif
- C. Pneumothorax simple
- D. Péricardite
- E. Pneumonie

Réponse : A

38. Patiente 28 ans, douleur thoracique antérieure reproduite à la palpation, ECG normal, CRP normale.

Quel diagnostic retenir ?

- A. Syndrome de Tietze
- B. SCA ST–
- C. Pleurésie sèche
- D. Reflux gastro-œsophagien
- E. Zona pré-éruptif

Réponse : A

39. Patiente 60 ans, douleurs constrictives rétrosternales déclenchées au repas, ECG normal, douleur améliorée par trinitrine.

Quel diagnostic retenir ?

- A. Angor instable
- B. Spasme œsophagien
- C. Pleurésie
- D. Pneumonie
- E. Douleur psychogène

Réponse : B

40. Patiente 64 ans, fièvre, douleur basi-thoracique, dyspnée, matité basale, souffle tubaire.

Diagnostic ?

- A. Pneumonie
- B. Pleurésie liquidienne
- C. Pneumothorax
- D. Reflux gastro-œsophagien
- E. Douleur psychogène

Réponse : A

41. Homme 50 ans, douleur thoracique localisée, augmentée à la palpation, ECG normal, radio normale.

Quel diagnostic ?

- A. Douleur pariétale
- B. Pneumothorax
- C. Pleurésie
- D. Angor instable
- E. Pancréatite

Réponse : A

42. Homme 64 ans, douleur thoracique constrictive 15 min, ECG normal, troponine US négative à H0.

Conduite ?

- A. Répéter troponine 1h
- B. Coronarographie immédiate
- C. Surveillance à domicile
- D. Répéter ECG
- E. Exclure SCA si troponine négative à H0

Réponse : A,D

43. Douleur thoracique 45 min, ECG : ST+ convexe V2–V5.

Prochaine étape ?

- A. Attendre troponine
- B. Fibrinolyse ou angioplastie urgente
- C. Radio thorax au lit
- D. Antiagrégation immédiate
- E. Échographie cardiaque

Réponse : B, D

44. Femme 68 ans, diabétique, douleurs épigastriques, ECG normal, troponine négative. **Que faire ?**

- A. Exclure SCA
- B. Répéter ECG et troponine
- C. Scanner abdominal d'emblée
- D. Coroscanner possible si proba faible
- E. Garder sous surveillance USIC

Réponse : B, D, E

45. Homme 50 ans, douleur transfixiante migratrice, asymétrie TA.

Conduite ?

- A. ECG systématique
- B. D-dimères si probabilité faible
- C. Angioscanner thoracique si suspicion forte
- D. Coronarographie
- E. TTT antihypertenseur immédiat

Réponse : A, B, C, E

46. Femme 32 ans, post-partum, douleur thoracique brutale, asymétrie tensionnelle , suspicion dissection type A. Angioscanner non dispo.

Quels examens alternatifs ?

- A. Écho transthoracique
- B. Écho transœsophagienne
- C. Coroscanner
- D. IRM thoracique
- E. Radio thorax seule

Réponse : A, B

47. Patient 42 ans, dyspnée brutale, Suspicion d'embolie pulmonaire, Wells simplifié = 1.

Étape suivante ?

A. D-dimères

B. Angioscanner thoracique direct

C. ECG

D. Écho cardiaque

E. Coronarographie

Réponse : A, C

48. Patient 72 ans, dyspnée brutale, Wells = 5.

Conduite ?

- A. Dosage D-dimères
- B. Angioscanner thoracique immédiat
- C. Écho cardiaque si instable
- D. Coroscanner
- E. ECG systématique

Réponse : B, C, E

49. Homme 65 ans, EP suspectée, choc, SaO₂ 70%, patient non transportable. **Examen clé ?**

- A. Angioscanner
- B. Écho cardiaque au lit
- C. Scintigraphie
- D. D-dimères
- E. Coroscanner

Réponse : B

50. Homme 30 ans, douleur précordiale majorée par l'inspiration, ECG : ST concave diffus + PQ sous-décalé. **Quels autres examens complémentaires utiles à demander ?**

- A. Troponine
- B. Écho cardiaque
- C. Coronarographie
- D. Angioscanner
- E. CRP

Réponse : A, B, E

51. Femme 40 ans, sans antécédents , douleur thoracique localisée, reproduite palpation, ECG normal, radio normale.

Quel autre examen complémentaire à demander en immédiat ?

- A. Aucun
- B. Écho cardiaque
- C. Coroscanner
- D. D-dimères
- E. Troponine

Réponse : A

52. Homme 50 ans, pyrosis, brûlure post-prandiale, ECG normal.

Conduite ?

- A. IPP test thérapeutique
- B. Écho cardiaque systématique
- C. Coroscanner
- D. FOGD si atypie ou persistance
- E. D-dimères

Réponse : A, D

53. Homme 22 ans, douleur thoracique droite brutale, tympanisme, abolition MV, stable hémodynamiquement.

Étape suivante ?

- A. Radio thorax
- B. Drainage immédiat
- C. Scanner thorax
- D. ECG
- E. Observation si minime

Réponse : A, E

54. Homme 60 ans, douleur épigastrique transfixiante dorsale, lipase 4×N, ECG normal. **Quel examen est utile ?**

- A. Scanner abdominal
- B. Coronarographie
- C. Angioscanner thoracique
- D. Écho cardiaque
- E. D-dimères

Réponse : A

55. Patient 70 ans, douleur thoracique brutale, instabilité hémodynamique. **Quels diagnostics vitaux éliminer en priorité ?**

- A. EP grave
- B. SCA ST+
- C. Dissection aortique type A
- D. Pneumothorax compressif
- E. Péricardite sèche

Réponse : A, B, C, D

56. Quel examen doit TOUJOURS être fait en première intention aux urgences devant toute douleur thoracique précordiale gauche ?

- A. ECG 18 dérivations
- B. D-dimères
- C. Radio thorax
- D. Troponine
- E. Scanner thorax

Réponse : A

57. Patient avec douleur thoracique gauche aiguë, stable. ECG normal.

Étape suivante ?

- A. Troponine US H0-H1
- B. Radio thorax
- C. Score de Wells si suspicion EP
- D. Examen systématique de tous les pouls
- E. Echographie cardiaque immédiate

Réponse : A, B, C, D

58. Devant un SCA ST+, quel examen n'a pas sa place dans la démarche immédiate ?

A. ECG

B. Troponine

C. Coronarographie en urgence

D. Fibrinolyse si absence de salle de coro rapide

E. Radiographie thoracique au lit si œdème pulmonaire

Réponse : B

59. Patient avec douleur typique, ECG normal, troponine H0 normale.

Quelle démarche est correcte ?

- A. Exclure SCA d'emblée
- B. Répéter troponine à H1/H3
- C. Refaire ECG répétés
- D. Surveillance hospitalière
- E. coroscanner

Réponse : B, C,D

60. Quel est l'examen de référence en urgence devant une suspicion de dissection aortique stable ?

- A. Angioscanner thoraco-abdomino-pelvien
- B. Coronarographie
- C. Écho cardiaque transthoracique
- D. Radio thorax
- E. IRM thoracique

Réponse : A

61. Suspicion EP, Wells = 5, **Quelle démarche est adaptée ?**

- A. D-dimères
- B. Angioscanner thoracique
- C. Écho cardiaque si état instable
- D. Coroscanner
- E. Scintigraphie V/Q en cas de contre-indication au scanner

Réponse : B, C, E

62. Quel diagnostic doit être recherché en priorité devant douleur thoracique brutale et instabilité hémodynamique ?

- A. SCA ST+
- B. EP massive
- C. Dissection aortique type A
- D. Pneumothorax compressif
- E. Douleur pariétale

Réponse : A,B, C, D